جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سعاد عبدالرؤف عبدالرازق عويس
المحافظة : بني سويف **الحي / المدينة :** ناصر **العنوان :** الحمام
رقم البطاقة : 26707092200447 **رقم التليفون :** 01118479568 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 09-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 09-07-1967 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سعاد عبدالرؤف عبدالرازق عويس
National ID: 26707092200447

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



عبد الرؤف عبد الرازق عرب

قرية الحمام

مركز ناصر - بني سويف

٢٦٧٠٧٠٩٢٢٠٠٤٤٧

KE5314596

DMS

مصطفى عبد الرحمن





٢٦٧٠٧٠٩٢٢٠٠٤٤٧ ٢٠٢٣/٠٩

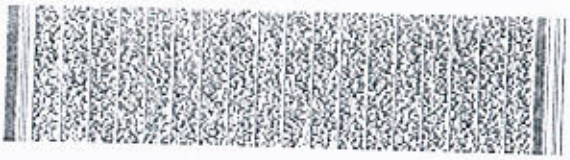
ربة منزل

انثى مسلمة متزوجة

جمال زكريا محمود الهنا

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٩/٢٣

١



National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
إداره المعمل
قسم الباثولوجى

Pathology Report

Name: سعاد عبد الرؤوف عبد الرازق Age: 50 years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: Tru cut biopsy.

Date: 10/12/2019

Lab. Number: 1371 Hospital Number: مبادرة/2019 استلم

Gross Description:

Two partly fragmented greyish white tissue cores, the longest was; 1.6 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of section prepared breast tissue core, infiltrated by invasive malignant growth, formed of cords and trabeculae of moderately anaplastic ductal epithelial cells, with desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Invasive mammary carcinoma GII, of terminal duct unit, for IPT: (ER, PR, Her2 & Ki67).

Prof. Dr. Lubna Omar *Prof. Dr. Essam Ayad*

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: سعاد عبد الروؤف عبد الرازق	
MR. : 1476	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with triple-negative breast cancer (CT3, no metastatic disease, ER8/8, PR8/8, HER2-negative) and received neoadjuvant chemotherapy followed by radiation therapy and breast-conserving surgery in June 2020. Adjuvant tamoxifen was initiated and subsequently switched to letrozole (Femara) in November 2022 in conjunction with zoledronic acid (Zometa).

The patient presented for a Femara refill and was noted to have dyspnea; a chest CT was ordered, which demonstrated right basal subpleural mass (R BSM) and pleural effusion (PAUS). The imaging results are pending.

Follow-up imaging in July 2026 showed a normal mammogram, a calcified gallbladder with an atrophic kidney and a uterine fibroid on ultrasound, and a goiter with calcification on chest CT. The patient is scheduled for a neck ultrasound and a follow-up visit for Femara on 2 November 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Souad Abdalrwaf Abdel Razek Owais	Date : 23/03/2023
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 11893

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

I Chest:-

- Right upper lobe anterior segment sub-pleural reticulations likley post theraputic sequel.
- Small right upper lobe fissural based nodule is seen measuring about 5 mm.
- No otherwise sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Relatively small sized left kidney is noted showing no stones or back-pressure changes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of the right kidney with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Souad Abdalrwaf Abdel Razek Owais	Date : 23/03/2023
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 55 Year(s)
Medical ID:	Pat. ID: 11893

- Bulky uterus with anterior wall fibroid is seen measuring about 5.5 cm.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.
- No lytic or sclerotic lesions.

Opinion:

Known case of breast cancer showing:

- ***Small right upper lobe fissural based nodule likely of benign nature.***
- ***Bulky uterus with anterior wall fibroid***

Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc

Signature Prof. Menna Tallah Hanafy
27/03/2023 03:37 م

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

وحدة ذات الأولوية

القصر العيني

وحدة تشخيص امراض الثدى

قسم الباثولوجى

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Patient Name: سعاد عبد الرءوف عبد الرازق

lab.No:2020-27/ (4TM)

Date: 1 /2020

Sex: Female

CLINICAL DATA: A case of breast cancer, for estrogen, progesterone receptors and Her-2/neu.

PROCEDURE:

Sections were prepared from paraffin blocks treated for (ER clone SP1), (PR clone 1E2), (Her 2 neu-clone 4B5) automatically stained in Bench mark ET (VENTANA) using ULTRA VIEW DAB Detection Kit, Hematoxylin as counter stain.

RESULTS:

Examination of sections treated for ER and PR receptors revealed intense nuclear staining in most of tumor cells by chromogen.

Examination of sections treated for Her 2/neu revealed no membranous staining of tumor cells by chromogen

CONCLUSION:

Tumor Cells Were:

- *Positive* For ER & PR, Score 8/8.
- *Negative* For Her-2/neu, (Score 0).

Comment: All controls show appropriate reactivity. The H&E slide as well as paraffin block were re-enclosed back

PROF. DR. AHMED ABD AL-AZIZ

PROF. DR. SAMIA GABAL

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: SOAD A	*Date of birth: 09/07/1967*
Arabic Name: سعاد عبدالرؤوف	*Patient Gender: F*
Patient RIS ID: 323609	*Exam Date: 30/03/2023*
Patient HIS ID: 123006054	
Written by:	Approved by:
Dr. Hoda Fathy	Dr. Hoda Fathy

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (26-3-2023)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

- No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

- No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Dr.Omnia Talaat,MD

Much Obliged

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]